

质子泵抑制剂与其他药物相互作用的药学监护实践

李玲

(阳光融和医院 药学部, 山东 潍坊 261400)

摘要:目的 通过药学监护质子泵抑制剂与其他药物之间的相互作用来确保患者的临床用药安全。方法 选取 2010 年至 2019 年于本院因应用质子泵抑制剂而出现药物不良反应 80 例患者作为本次的研究对象, 统计其不良反应类型并分析质子泵抑制剂与其他药物之间的相关作用, 提出以保证患者用药安全为切入点的药学服务。结果 质子泵抑制剂与其他药物相互作用所引起的不良反应主要为消化系统不良反应, 其次为神经内分泌系统不良反应、过敏反应、视力损伤、感染等。结论 质子泵抑制剂与许多药物配伍使用可引发不良反应或导致药效降低, 临床药师应在药学监护中避免质子泵与这些药物联合使用。

关键词: 质子泵抑制剂; 其他药物; 相互作用; 药学监护; 实践

中图分类号: R93

文献标识码: A

DOI: 10.19613/j.cnki.1671-3141.2019.67.008

本文引用格式: 李玲. 质子泵抑制剂与其他药物相互作用的药学监护实践[J]. 世界最新医学信息文摘, 2019, 19(67):15-16.

Pharmaceutical Care Practice of Interactions Between Proton Pump Inhibitor and Other Drugs

LI Ling

(Department of Pharmacy, Sunshine Union Hospital, Weifang Shandong 261400)

ABSTRACT: Objective To guarantee the clinical medication safety of patients through the pharmaceutical care of interactions between proton pump inhibitor and other drugs. **Methods** 80 patients with adverse drug reactions due to the application of proton pump inhibitor who were treated in Sunshine Union Hospital from 2010 to 2019 were selected for study. Statistics on the types of adverse reactions was made and the interactions between proton pump inhibitor and other drugs were analyzed. Moreover, the pharmaceutical care with guarantee of the medicine safety of patients was starting point was proposed. **Results** The adverse reactions caused by the interactions between proton pump inhibitor and other drugs mainly included the adverse reactions of digestive system, followed by the adverse reactions of neuroendocrine system, allergic reactions, visual impairment, infection, etc. **Conclusion** The use of proton pump inhibitor in combination with many drugs may lead to adverse reactions or reduce efficacy. Therefore, clinical pharmacists shall avoid the use of proton pump inhibitor in combination with these drugs in pharmaceutical care.

KEY WORDS: Proton pump inhibitor; Other drugs; Interaction; Pharmaceutical care; Practice

0 引言

所谓药物相互作用, 是指在同一时间同时使用或在较短的时间内相继性地使用 2 种或 2 种以上药物时出现严重不良反应、药效降低或增加的情况, 导致药物相互作用发生的原因主要是不同药物所含有的成分发生化学反应, 使得其性质发生改变, 这种相互作用有强有弱, 持续时间有长有短, 所产生的影响有好有坏。临床药师可以通过药学监护实践来发现, 通过在联合用药中进行仔细的观察与针对性的处理来避免不良反应的发生。本文选取 2010 年-2019 年期间于本院因应用质子泵抑制剂而出现药物不良反应 80 例患者作为本次的研究对象, 试统计其不良反应类型并分析质子泵抑制剂与其他药物之间的相关作用。

1 资料和方法

1.1 一般资料。选取 2010 年至 2019 年于本院因应用质子泵抑制剂而出现药物不良反应 80 例患者作为本次的研究对象, 回顾分析其基本资料: ①性别构成: 男性 46 例, 女性 34 例; ②年龄分布: 最小者 19 岁, 最大者 79 岁, 平均 (49.29 ± 12.20) 岁。

1.2 方法。调阅患者发生不良反应的具体事件详情, 归类不良反应类型, 分析质子泵抑制剂与其他药物联合应用所引发的不良反应。

1.3 观察指标。观察患者出现不良反应的类型。

1.4 统计学方法。在 SPSS 19.0 版统计学软件中纳入本研究所有患者的临床数据, 计数资料采用 $n(\%)$ 表示, 行 χ^2

检验。

2 结果

质子泵抑制剂与其他药物相互作用所引起的不良反应主要为消化系统不良反应, 其次为神经内分泌系统不良反应、过敏反应、视力损伤、感染等。具体见表 1。

3 讨论

以奥美拉唑、雷贝拉唑、埃索美拉唑等为代表的质子泵抑制剂是强效抑酸剂, 其所引起的不良反应主要为消化系统不良反应, 与其他药物配伍使用时可能会引起神经系统不良反应、过敏等问题, 这一点可以从结果中患者 37.5% 的消化系统不良反应率、20% 的神经内分泌系统不良反应和过敏反应率、15% 的感染发生率等得到证实。容易在配伍使用质子泵抑制剂时出现不良反应或导致药效降低的药物有: ①伊曲康唑或酮康唑等抗真菌药物。伊曲康唑和酮康唑均是临床上较为常用的抗真菌药物, 由于酸性环境有助于伊曲康唑和酮康唑的吸收, 因此用药时需要患者胃酸大量分泌。然而质子泵抑制剂可以快速、高效地抑制胃酸的分泌, 对幽门螺杆菌等进行清除, 进而快速彻底地治愈溃疡, 因此若是将伊曲康唑、酮康唑与质子泵抑制剂联合使用, 便会导致伊曲康唑、酮康唑的胃内吸收率显著降低, 而血药浓度的下降无疑会导致治疗效果降低^[1]。②地高辛。地高辛主要用于治疗室上性心律失常和充血性心力衰竭, 部分患有上述疾病的患者可能伴有胃肠道风险, 需要联合使用质子泵抑制剂与地高辛。部分研究显示使用质子泵抑制剂——奥美拉唑后患者的胃酸分

表 1 不良反应类型分布 (n, %)

不良反应	消化系统不良反应	神经内分泌系统不良反应	过敏反应	视力损伤	感染	其他
发生例数 (例)	30	16	16	5	12	1
占比 (%)	37.50	20.00	20.00	6.25	15.00	1.25

泌得到抑制,地高辛口服后具有了更高的生物利用度^[2];然而,药 学 监 护 中 发 现 也 有 患 者 在 联 合 使 用 质 子 泵 抑 制 剂——奥美拉唑与地高辛 3 个月 后 出 现 了 地 高 辛 中 毒 问 题^[3]。 当 然,奥美拉唑并不是唯一一种与地高辛联合应用后引发不良相互作用的质子泵抑制剂,临床药师发现雷贝拉唑和地高辛若是联合使用也会因为胃部 pH 值的变化而引发不良相互作用。因此,在伴有胃肠道风险的心律失常或心力衰竭患者的用药中,应该停用质子泵抑制剂 1-2 周后再使用地高辛。③氯吡格雷。作为一种 ADP 受体阻断剂,氯吡格雷可以结合血小板膜表面的 ADP 受体,阻止纤维蛋白原和糖蛋白受体的结合,使得血小板无法聚集,因此这种药物常被用于预防和治疗因血小板高聚集而引发的心脑疾病、动脉循环障碍疾病,如:脑卒中、心肌梗死、外周动脉疾病。然而无法忽视的是,氯吡格雷会提高患者发生胃肠道出血的风险。对于这种情况,美国心脏病学会与美国心脏学会在其制定的指南性文件中指出,可以为单用阿司匹林或氯吡格雷、联用这两种药物的有消化道出血病史的患者加用质子泵抑制剂,以降低其出血风险^[4]。在盛一梁的研究《质子泵抑制剂与临床常用药物相互作用的研究进展》中,临床药师观察了 620 例非 ST 段抬高型急性冠脉综合征患者的用药状况,这 620 例患者除了接受标准的二联抗血小板治疗,同时也加用了泮托拉唑或奥美拉唑,结果发现患者的血小板计数并没有受到影响^[5];然而,临床药师又对 124 例进行 PCI 手术的患者进行了观察,这些患者均标准剂量使用氯吡格雷与阿司匹林,但是使用奥美拉唑的患者其血小板抗血管扩张剂刺激磷酸蛋白指数则出现了异常,这意味着奥美拉唑这种质子泵抑制剂会对二联抗血小板治疗的效果产生明显的影响,引发不良反应^[6]。究其原因,主要是奥美拉唑的代谢由 CYP2C19 主导,其可以与氯吡格雷产生不良相互作用,因此若要是使用氯吡格雷的患者联用质子泵抑制剂,应选择不会对疗效产生明显影响的泮托拉唑。④缓释制剂或肠溶制剂。缓释制剂是指用药后药物可以在较长的时间内不间断地释放药效以发挥出药物长效作用的药品剂型^[7];而肠溶制剂则是指药物在口服后不会在指定的酸性介质中释放或极少地释放,而是在指定的时间内于 6.8pH 值的磷酸盐缓冲液中全部释放或大部分释放的药品剂型。这些剂型对环境 pH 值有较高的要求,而使用质子泵抑制剂会导致胃酸分泌受到抑制,从而使胃内具有更高的 pH 值,缓释制剂或肠溶制剂会受到胃内酸碱度的影响而不在指定条件下

释放,从而导致治疗效果大打折扣^[8]。⑤地西泮、苯妥英钠。地西泮为苯二氮卓类药物,可以松弛骨骼肌,达到抗焦虑与抗癫痫作用,苯妥英钠则是抗癫痫与抗惊厥的功效,这两种药物与质子泵抑制剂联用均可引发不良相互作用。临床发现,苯妥英钠奥美拉唑联合应用可导致苯妥英钠的半衰期延长约 45%,使药时曲线下面积增加约 25%,原因是奥美拉唑对苯妥英钠的代谢带来了抑制,使其清除率下降^[9];质子泵抑制剂与肝药酶 CYP 亲和力较高,与地西泮联用会对其代谢造成影响,使其清除时间延长。例如,兰索拉唑、泮托拉唑、奥美拉唑会抑制 CYP219、CYP3A4 同工酶的代谢,使地西泮无法顺利从肝脏代谢^[10]。

4 结论

通过抑制胃酸分泌质子泵抑制剂可以有效治疗许多消化系统疾病,但长期应用易引起各种不良反应,临床应加强对质子泵抑制剂不良反应的监测,特别是与其他药物配伍使用时更要多加注意,以确保药物合理应用,减少不良反应发生。

参考文献

[1] 李陆,房德敏,陈青.住院患者质子泵抑制剂应用合理性评价[J].天津药学,2017,29(06):46-48.

[2] 熊天增.住院患者质子泵抑制剂(PPIs)临床使用的合理性分析[J].北方药学,2017,14(09):180-181.

[3] 张拥军,郭曙光,方健,等.住院患者质子泵抑制剂使用合理性分析[J].中国药业,2017,26(21):82-84.

[4] 蔡黎.质子泵抑制剂在临床使用中的应用分析[J].北方药学,2017,14(09):100-101.

[5] 盛一梁,沈建飞,吴嫣,等.质子泵抑制剂与临床常用药物相互作用的研究进展[J].中国医院用药评价与分析,2017,17(11):1582-1584.

[6] 许娅,甘向辉.临床使用质子泵抑制剂的临床药学分析[J].结直肠肛门外科,2016,22(S2):112-113.

[7] 李海燕,胡斌.质子泵抑制剂与其他药物相互作用的药学监护实践[J].中国药物警戒,2016,13(07):429-432.

[8] 朱佩,袁晋青.P2Y₁₂受体拮抗剂与质子泵抑制剂相互作用的研究进展[J].心血管病学进展,2015,36(05):570-574.

[9] 高卫东.临床药师对于质子泵抑制剂注射剂合理使用的干预效果[J].临床合理用药杂志,2015,8(11):24-25.

[10] 钟秋红.质子泵抑制剂药物的不良反应与药物相互作用[J].北方药学,2014,11(05):102.

(上接第 14 页)

近端骨折的疗效比较[J].中华创伤骨科杂志,2016,18(7):592-596.

[2] 李乔红,吕云峰,潘学坤.微创锁定接骨板内固定术治疗肱骨近端骨折效果观察[J].山东医药,2017,57(46):81-83.

[3] Sakoma Y, Hirooka T. Relationship between the Axillary Nerve and Accompanying Vessels and Proximal Humeral Locking Plates in Japanese: An MRI Study[J].Acta Medica

Okayama,2017,71(6):525-529.

[4] 许华亮,李爱国,赖敏锋,等.经皮微创钢板内固定术治疗肱骨近端骨折的疗效观察[J].中国矫形外科杂志,2017,25(6):503-507.

[5] Ravindra A, Roebke A, Goyal K S. Cadaveric Analysis of Proximal Humerus Locking Plate Fit: Contour Mismatch May Lead to Malreduction[J]. Journal of Orthopaedic Trauma,2017,31(12):663-667.